



RUMAH SAKIT  
**PRIMA HUSADA**

**PEDOMAN  
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
RUMAH SAKIT  
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : [sekretariat@malang.rs-primahusada.com](mailto:sekretariat@malang.rs-primahusada.com)

[www.rs-primahusada.com](http://www.rs-primahusada.com)

---

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada  
Nomor 537.2/I-PDM/DIR/VI/2025

Tentang  
Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit

Disusun oleh :  
Ketua Tim PKBRS



( dr. Humaira rahma,Sp.Og )

Disetujui oleh :  
*Authorized Person*



( Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP )

Ditetapkan oleh :  
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



( dr. Nur Mazidah )

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan RidhoNya Pedoman Pelayanan keluarga berencana rumah sakit dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Pedoman Pelayanan keluarga berencana rumah sakit ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi semua pelayanan di Instalasi rawat jalan, ruang bersalin dan ruang operasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan keluarga berencana rumah sakit ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 1 Juni 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



**dr. Nur Mazidah**

---

## **TIM PENYUSUN**

### **PEDOMAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT**

#### **PENGARAH**

1. Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP
2. dr.Ari Putrianti,Sp.PK

#### **Pelaksana**

1. dr. Nur Mazidah
2. dr. Humaira,Sp.Og
3. Leni Puji Rahayu,Amd.Keb
4. Bdn. Nurul Azizah Jihad Fisabilillah,S.Tr.Keb

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....iii

TIM PENYUSUN .....iv

DAFTAR ISI .....v

DAFTAR GAMBAR .....vi

DAFTAR TABLE.....vi

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA.....7

    BAB I KETENTUAN UMUM.....8

    BAB II PENGORGANISASIAN .....9

    BAB III STANDAR FASILITAS .....9

    BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN .....9

    BAB IV MUTU .....11

    BAB VI MONITORING EVALUASI PELAPORAN.....11

    BAB VII PENUTUP .....12

PEDOMAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT.....13

    BAB I PENDAHULUAN.....13

        1.1 LATAR BELAKANG .....13

        1.2 TUJUAN .....14

        1.3 BATASAN OPERASIONAL .....14

        1.4 SASARAN .....14

        1.5 PENGERTIAN.....14

    BAB II STANDAR KETENAGAAN .....18

        2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia.....18

        2.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....18

        2.3 Distribusi Ketenagaan.....19

        2.4 Pengaturan Jaga.....20

    BAB III STANDAR FASILITAS .....21

        3.1 Denah Ruang .....21

        3.2 Standar Fasilitas .....21

    BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN.....24

        4.1 Pelayanan Keluarga berencana Yang Bisa Dilakukan di RSPH .....24

    BAB V TATA LAKSANA .....26

    BAB VI LOGISTIK .....27

    BAB VII KESELAMATAN PASIEN .....29

    BAB VIII KESELAMATAN KERJA .....32

    BAB IX PENINGKATAN MUTU .....34

    BAB X PENUTUP .....35

---

**DAFTAR GAMBAR**

Lampiran Gambar Denah Rumah Sakit Prima Husada Malang .....36

**DAFTAR TABLE**

Table 2.1 Kebutuhan Pemenuhan Kualifikasi SDM ..... 18

Table 2.2 Distribusi Ketenagaan ..... 19

Table 2.3 Pengaturan Jaga tim KBRS .....20

Table 3.1 Standar Fasilitas pelayanan Keluarga berencana Rumah sakit .....21

Table 6.1 Alat dan bahan .....27



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA  
NOMOR 537.2/I-PDM/DIR/VI/2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan jumlah kelahiran dan meningkatkan kualitas keluarga di Rumah Sakit Prima Husada, serta pelaksanaan rumah sakit tentang pasangan usia subur, maka perlu adanya Pedoman Kerja Tim KBRS (Keluarga Berencana Rumah Sakit) Rumah Sakit Prima Husada Malang;
  - b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang Nomor 537.2/I-PDM/DIR/VI/2025 Tentang pedoman pelayanan PKBRS sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Tim KBRS (Keluarga Berencana Rumah Sakit) Rumah Sakit Prima Husada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  3. Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang mengatur tugas dan fungsi BKKBN dalam pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
  4. Permenkes No. 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
  7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
  8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
  9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 537.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit Prima Husada.;



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA  
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
RUMAH SAKIT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Keluarga Berencana Adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, penjarangan dan penghentian kehamilan dan pengobatan kemandulan yang dilakukan secara sukarela.
- (2) Rumah Sakit Adalah semua sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik yang dilaksanakan selama 24 jam melalui upaya kesehatan perorangan.
- (3) Instalasi Adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (4) Pelayanan medik Adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas secara optimal.
- (5) Peralatan medis Adalah peralatan utama yang harus dimiliki RS untuk dapat melaksanakan pelayanan KB sesuai dengan metode kontrasepsi yang diberikan. 6. Peralatan non medis Adalah peralatan pendukung yang harus dimiliki oleh RS untuk melaksanakan pelayanan KB.
- (6) Pelayanan Kontrasepsi Merupakan upaya kesehatan dengan menggunakan metode tertentu untuk mengatur jarak kehamilan atau menghentikan kehamilan.
- (7) Kontrasepsi mantap Suatu tindakan untuk membatasi kelahiran dalam jangka waktu yang tidak terbatas melalui suatu tindakan operasi kecil dengan cara mengikat dan memotong saluran telur pada istri (tubektomi) atau mengikat dan memotong saluran sperma pada suami (vasektomi) atas permintaan yang bersangkutan secara sukarela.
- (8) Pelayanan KB di Rumah Sakit Adalah pelayanan medik dan non medik, yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan standard dan perkembangan iptek dengan menggunakan fasilitas dan sarana yang memenuhi ketentuan.





- (9) Pelayanan Konseling Adalah pelayanan untuk memberikan bantuan kepada klien dalam pengambilan keputusan pemilihan kontrasepsi yang cocok. Dalam memberikan pelayanan ini menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) ber-KB.
- (10) Penapisan Klien Suatu prosedur selektif yang sesuai dengan kebutuhan sebelum tindakan medis, antara lain menanyakan identitas, riwayat penyakit dan kehamilan serta melakukan pemeriksaan fisik.

## **BAB II**

### **PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Rumah sakit menetapkan tentang pelaksanaan PKBRS dalam bentuk tim PKBRS
- (2) Tim PKBRS d ketuai oleh dokter spesialis obgyn
- (3) Tim PKBRS dibentuk untuk melakukan koordinasi semua kegiatan KB secara terstruktur yang melibatkan staf klinis sesuai dengan ukuran,serta kompleksitas Rumah Sakit Prima Husada.
- (4) Segala yang berhubungan dengan rapat KB diatur oleh sekretaris Tim KB termasuk persiapan dan hasil rapat.
- (5) Tim KB membina hubungan dengan Komite/Tim lain di RS yang berhubungan dengan pelayanan pasien yang memiliki usia subur.
- (6) Rapat Tim KBRS dilakukan rutin satu bulan sekali.
- (7) Koordinasi antara Ketua Tim dengan anggota Tim KBRS dilakukan secara terstruktur dalam kegiatan pelayanan KB antara lain untuk menetapkan

## **BAB III**

### **STANDAR FASILITAS**

#### **Pasal 3**

- (1) Rumah sakit menyediakan ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan PKBRS
- (2) Tersedianya ruang konseling
- (3) Tersedia ruang pelayanan KB

## **BAB IV**

### **KEMAMPUAN PELAYANAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Rumah sakit merencanakan program Keluarga Berencana setiap tahun
- (2) Rumah sakit berupaya meningkatkan PKBRS dengan memasukan dalam rencana strategis ( rensa )
- (3) Perencanaan meliputi sasaran,alat dan bahan yang diperlukan untuk pelayanan KB



- (4) Rumah Sakit menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, peralatan penunjang pelayanan kontrasepsi dan tenaga Kesehatan yang sesuai kompetensi
- (5) Rumah sakit merencanakan anggaran untuk program PKBRS (RAB/RAK)

#### Pasal 5

- (1) Rumah sakit menetapkan dan melaksanakan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berperan dalam menurunkan angka kematian Ibu dan percepatan penurunan stunting
- (2) Rumah Sakit melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna.
- (3) Rumah sakit melaksanakan dan mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB
- (4) Rumah sakit meningkatkan kesiapan dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
- (5) Rumah sakit meningkatkan fungsi sebagai model dan pembinaan teknis dalam melaksanakan PKBRS.
- (6) Rumah sakit meningkatkan fungsi sebagai pusat rujukan pelayanan KB bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (7) Rumah sakit melaksanakan system pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS.
- (8) Rumah sakit melaksanakan kegiatan kapasitas untuk meningkatkan pelayanan PKBRS termasuk KB pasca persalinan dan pasca keguguran

#### Pasal 6

Pelayanan yang tidak bias dilakukan dirumah sakit akan dilakukan rujukan sesuai dengan ketentuan perundangan

#### Pasal 7

Semua staf yang melaksanakan program PKBRS dilakukan Pendidikan dan pelatihan :

- a. Contraceptive technology update (CTU)
- b. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)
- c. Komunikasi efektif dan educator
- d. Managemen resiko
- e. Hak pasien dan keluarga



## **BAB IV MUTU**

### **Pasal 8**

- 1) Mutu KB yang akan diukur:
  - a) Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.
  - b) Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
  - c) Kejadian tidak dilakukannya KB pasca persalinan pada ibu baru bersalin
  - d) Kejadian tidak dilakukannya KB pasca keguguran pada ibu pasca keguguran
- 2) KBRS ikut serta dalam proses peningkatan mutu dan keselamatan pasien bersama Panitia Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- 3) Setiap insiden yang terjadi pada pasien harus membuat laporan Insiden Keselamatan Pasien.
- 4) Manajemen resiko yang mungkin terjadi :
  - a) Alat-alat medis yang tidak lengkap/tidak tersedia
  - b) Alat medis atau alat kontrasepsi rusak
  - c) Kurangnya identifikasi pasien sebelum tindakan
  - d) Kesalahan pemberian obat kontrasepsi

## **BAB VI MONITORING EVALUASI PELAPORAN**

### **Pasal 9**

- 1) Rumah sakit melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS
- 2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada direktur
- 3) Pemantauan dan evaluasi dibahas dalam rapat tim yang dilakukan setiap 3 bulan sekali.

### **Pasal 10**

- (1) Sistem pelaporan anggota Tim KBRS kepada ketua Tim KBRS yang akan dibahas di organisasi dengan melibatkan semua anggota untuk mendapatkan hasil yang akurat
- (2) Pelaporan dibuat tiap 3 bulan sekali
- (3) Pelaporan disampaikan kepada instansi terkait seperti BKKBN dan Dinas kesehatan
- (4) Pelaporan dan analisis meliputi:
  - a. Ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.
  - b. Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB.
  - c. Ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB.
  - d. Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi baik metode kontrasepsi jangka Panjang ( MKJP ) dan non MKJP
  - e. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran



- f. Kejadian tidak dilakukannya KB pasca persalinan pada ibu baru bersalin
- g. Kejadian tidak dilakukannya KB pasca keguguran pada ibu pasca keguguran

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 11**

Setiap staf penyelenggara pelayanan Keluarga Berencana dirumah sakit wajib melaksanakan pedoman sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan direktur ini

### **Pasal 12**

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 1 Juni 2025  
Direktur RS Prima Husada Malang



**dr. Nur Mazidah**



LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
PRIMA HUSADA MALANG  
NOMOR 537.2/I-PDM/DIR/VI/2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAYANAN  
KELUARGA BERENCANA RUMAH  
SAKIT

## PEDOMAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Republik Indonesia tentang Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengatur teknis pelaksanaan seperti Peraturan BKKBN No. 18 Tahun 2023 (perubahan atas peraturan sebelumnya), Peraturan BKKBN No. 1 Tahun 2023, hingga Peraturan BKKBN No. 6 Tahun 2024 yang menyangkut manajemen, operasional, dan pelayanan KB, serta yang paling baru adalah Peraturan BKKBN No. 2 Tahun 2025 tentang evaluasi dan pencatatan pelayanan KBPP, semuanya bertujuan mewujudkan keluarga berkualitas dan pengendalian penduduk yang seimbang.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang menjadi indikator kualitas kesehatan masyarakat di suatu negara, data terbaru menunjukkan AKI 189 per 100.000 kelahiran hidup (data BPS 2020), namun data Kemenkes 2023 mencatat 4.129 kematian ibu, sementara AKB 2023 mencapai 29.945 kasus, masih tergolong tinggi di Indonesia yaitu. Penyebab utama AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) terbaru masih didominasi oleh perdarahan pasca-persalinan, infeksi (sepsis neonatorum), gangguan pernapasan, dan kelainan bawaan, **ditambah** faktor keterlambatan diagnosis dan penanganan yang kurang optimal, dengan lebih dari 90% kematian bayi terjadi di rumah sakit, menurut data dan laporan terbaru Kementerian Kesehatan

Salah satu ruang lingkup dalam kesehatan reproduksi adalah keluarga berencana. Pelayanan KB di Rumah Sakit merupakan salah satu mata rantai pelayanan KB yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan yang sangat potensial dalam pelayanan KB, terutama dalam penanganan kasus rujukan, pengayoman medis maupun pelayanan metode KB yang tidak dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan lainnya/dibawahnya

Salah satu tantangan dalam pelayanan KB adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan KB. Oleh karena itu dibutuhkan Pedoman sebagai acuan dalam memberikan pelayanan KB yang berkualitas. Revisi ini dilakukan mengingat banyaknya perkembangan kebijakan dan strategi program KB yang mempengaruhi manajemen pelayanan KB

Pedoman Kerja Tim KBRS ini merupakan pedoman untuk melaksanakan kebijakan pelayanan pada pasangan usia subur di rumah sakit Prima Husada yang tercakup dalam ruang lingkup dan batasan operasional.



## 1.2 TUJUAN

### 1.2.1 Tujuan Umum

Meningkatkan kemampuan pengelola program KB dalam hal manajemen pelayanan KB sebagai upaya mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

### 1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan kemampuan pengelola program KB dalam pengorganisasian pelayanan KB.
- 2) Meningkatkan kemampuan pengelola program KB dalam perencanaan pelayanan KB.
- 3) Meningkatkan kemampuan pengelola program KB dalam pelaksanaan pelayanan KB.
- 4) Meningkatkan kemampuan pengelola program KB dalam pemantauan dan evaluasi pelayanan KB

## 1.3 BATASAN OPERASIONAL

Semua jenis pelayanan kontrasepsi berikut penanganan efek samping, komplikasi dan kegagalan pelayanan kontrasepsi serta Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya

## 1.4 SASARAN

Sasaran program pelayanan KB di RS adalah :

1. Pasangan usia subur
2. Klien rujukan komplikasi dan efek samping
3. Klien pasca persalinan dan pasca keguguran
4. Pasangan yang infertil
5. Masyarakat.

## 1.5 PENGERTIAN

1. Keluarga Berencana Adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, penjarangan dan penghentian kehamilan dan pengobatan kemandulan yang dilakukan secara sukarela.
2. Rumah Sakit Adalah semua sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik yang dilaksanakan selama 24 jam melalui upaya kesehatan perorangan.
3. Instalasi Adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
4. Pelayanan medik Adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas secara optimal.
5. Peralatan medis Adalah peralatan utama yang harus dimiliki RS untuk dapat melaksanakan pelayanan KB sesuai dengan metode kontrasepsi yang diberikan.
6. Peralatan non medis Adalah peralatan pendukung yang harus dimiliki oleh RS untuk melaksanakan pelayanan KB.



7. Pelayanan Kontrasepsi Merupakan upaya kesehatan dengan menggunakan metode tertentu untuk mengatur jarak kehamilan atau menghentikan kehamilan.
8. Kontrasepsi mantap Suatu tindakan untuk membatasi kelahiran dalam jangka waktu yang tidak terbatas melalui suatu tindakan operasi kecil dengan cara mengikat dan memotong saluran telur pada istri (tubektomi) atau mengikat dan memotong saluran sperma pada suami (vasektomi) atas permintaan yang bersangkutan secara sukarela.
9. Pelayanan KB di Rumah Sakit Adalah pelayanan medik dan non medik, yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan standard dan perkembangan iptek dengan menggunakan fasilitas dan sarana yang memenuhi ketentuan.
10. Pelayanan Konseling Adalah pelayanan untuk memberikan bantuan kepada klien dalam pengambilan keputusan pemilihan kontrasepsi yang cocok. Dalam memberikan pelayanan ini menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) ber-KB.
11. Penapisan Klien Suatu prosedur selektif yang sesuai dengan kebutuhan sebelum tindakan medis, antara lain menanyakan identitas, riwayat penyakit dan kehamilan serta melakukan pemeriksaan fisik.
12. KB Pasca persalinan Adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari.
13. KB Pasca Keguguran Adalah pelayanan KB yang diberikan setelah mengalami keguguran sampai kurun waktu 14 hari.
14. Klien Adalah salah satu Pasangan Usia Subur (PUS) yang merupakan calon atau peserta KB.
15. Alokasi Program Adalah jenis dan alat metode kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan program KB.
16. Peserta KB Baru Adalah PUS yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau PUS yang kembali menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan atau keguguran.
17. Peserta KB Aktif Adalah peserta KB yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi secara terus menerus tanpa diselingi kehamilan.
18. Macam-Macam KB
  - a. Metode laktasi
  - b. Kondom
  - c. Pil KB
  - d. KB suntik
  - e. Implan atau susuk
  - f. IUD atau spiral
  - g. Steril
19. Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, Efek Samping
  - a. Metode Laktasi

Adalah Metode KB yang cocok untuk ibu nifas, syaratnya :

    - 1) Menyusui bayi secara eksklusif setelah melahirkan (hanya asi secara penuh, teratur dan sesering mungkin)
    - 2) Belum haid
    - 3) Efektif hanya sampai 6 bulan
  - b. Kondom
    - 1) Keuntungan :
      - a) Efektif bila digunakan dengan benar
      - b) Tidak mengganggu asi
      - c) Murah dan mudah didapat
      - d) Mencegah penyakit menular seksual





- 2) Keterbatasannya :
  - a) Efektifnya tidak terlalu tinggi
  - b) Agak mengganggu hubungan seksual
  - c) Bisa terjadi alergi bahan dasar kondom

c. Pil KB

- 1) Kelebihan :
  - a) Efektif bila digunakan dengan benar
  - b) Tidak mengganggu hubungan seksual
  - c) Harus diminum setiap hari
- 2) Terdapat 2 macam :
  - a) Pil kombinasi (berisi 2 hormon yaitu esterogen dan progesteron)
    - (1) Tidak untuk ibu menyusui
    - (2) Contoh microgynon, mercilon, diane, yasmin dan lain-lain
  - b) Mini pil (berisi 1 hormon yaitu progesteron)
    - (1) Tidak mengganggu asi, cocok untuk menyusui
    - (2) Dapat terjadi gangguan haid (siklus haid memendek atau memanjang, tidak haid, perdarahan bercak)

Contoh : excluton, micoolat, dan lain-lain

d. KB Suntik

- 1) Kelebihan :
  - a) Efektifitasnya tinggi, efek samping sedikit
  - b) Tidak mengganggu hubungan seksual
- 2) Terdapat 2 macam :
  - a) Suntikan 1 bulan :
    - (1) Mengandung esterogen dan progesteron
    - (2) Mengganggu produksi asi
    - (3) Harus datang setiap 1 bulan untuk suntik
  - b) Suntikan 3 bulan :
    - (1) Mengandung progesteron saja
    - (2) Tidak mengganggu produksi asi
    - (3) Harus datang setiap 3 bulan untuk suntik
    - (4) Dapat terjadi gangguan haid

e. Implan atau Susuk KB

Dipasang dilengan atas bagian dalam, ada yang berisi 2 batang dan 1 batang, efektif selama 3 tahun.

- 1) Kelebihan:
  - a) Mengandung hormon progesteron
  - b) Tidak mengganggu produksi asi
  - c) Tidak mengganggu hubungan seksual
  - d) Dapat dicabut setiap saat sesuai kebutuhan dan kembali kesuburan cepat





- 2) Kekurangan
  - a) Dapat terjadi perubahan pola haid
  - b) Dapat terjadi perubahan berat badan

f. IUD (intra uterine device) / spiral

Spiral ditanam di dalam rahim untuk mencegah pertemuan sel telur dan sperma.

1) Kelebihan :

- a) Efektifitas tinggi
- b) Jangka panjang (8 sampai 10 tahun)
- c) Tidak mengganggu produksi asi
- d) Tidak mengganggu hubungan seksual
- e) Tidak mempengaruhi berat badan

2) Kelebihan :

- a) Haid bisa lebih banyak

g. Kontrasepsi mantap (steril)

Khusus digunakan untuk pasangan suami istri yang benar-benar tidak menginginkan tambah anak lagi.

- (1) Dilakukan dengan cara pembedahan (bisa bius lokal)
- (2) Harus dilakukan oleh dokter terlatih
- (3) Sangat efektif dan bersifat permanen
- (4) Tidak ada efek samping
- (5) Tidak ada perubahan fungsi seksual, contoh : Metode operatif wanita, Metode operatif pria



## BAB II

### STANDAR KETENAGAAN

#### 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Sumber daya insani merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk mendukung dan memberikan pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit yang berkesinambungan. Pengetahuan dan sikap sumber daya insani dalam hal ini adalah petugas kesehatan akan mempengaruhi keefektifan penyediaan pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit.

Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah mempunyai keterampilan klinik dengan mengikuti training yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit harus mendapatkan pelatihan yang lebih spesifik dan secara khusus. Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit membutuhkan tenaga kesehatan yang berdedikasi dan mempunyai keterampilan yang memadai. Adapun Petugas Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit terdiri dari :

Lampiran Table 2.1 Kebutuhan Pemenuhan Kualifikasi SDM

| No | Nama Jabatan | Kualifikasi Formal | Sertifikasi      |
|----|--------------|--------------------|------------------|
| 1  | Ketua TIM    | Dokter spesialis   | USG Dasar        |
| 2  | Sekretaris   | Bidan              | APN<br>MU        |
| 3  | Anggota      | Bidan              | APN<br>CTU<br>MU |

#### 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Direktur Utama
  - a. Merupakan penanggung jawab utama dalam PKBRS
  - b. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan institusi KB setempat untuk kegiatan yang berkaitan dengan layanan KB.
2. Penanggung jawab PKBRS
  - a. Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan PKBRS adalah dokter.
  - b. Berkoordinasi dengan unit/bagian lain terkait pelayanan KB di RS.
  - c. Memberikan laporan penyelenggaraan pelayanan KBB di RS kepada Direktur Utama.
  - d. Membuat perencanaan kebutuhan alokon.
  - e. Melakukan monev pelayanan KB di RS
3. Penanggung jawab layanan medis KB
  - a. Sebagai penanggung jawab layanan medis KB adalah bagian Obgyn
  - b. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan konseling, tindakan medis di poli KB dan tindakan operatif.
  - c. Dibantu oleh tenaga pelayanan kontrasepsi yang terdiri dari dokter spesialis (obsgyn, anestesi), dokter umum terlatih dan bidan terlatih.
  - d. Tenaga pelayanan kontrasepsi tersebut wajib memberikan pelayanan



kontrasepsi sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku (SOP) serta memberikan yang bermutu sesuai standar profesi.

4. Penanggung jawab promosi
  - a. Sebagai penanggung jawab promosi dalam PKBRS dapat berasal dari unsur PKRS (promosi Kesehatan RS) atau bidan/perawat terlatih yang akan mengayomi petugas PKBRS.
  - b. Dalam pelaksanaan sehari-hari berkoordinasi dengan unit/bagian lain terkait sesuai kebutuhan.
  - c. Memberikan kegiatan KIE/motivasi kepada calon akseptor potensial/klien serta peserta keluarga KB baru dan KB aktif sasaran konseling adalah peserta/keluarga KB baru dan KB aktif.
5. Penanggung jawab administrasi
  - a. Bertanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di RS, termasuk pencatatan dan pelaporan penggunaan alokon.
  - b. Memberikan laporan kepada Penanggung jawab PKBRS.
6. Intalasi / Bagian Farmasi RS
  - a. Bertanggung jawab dalam penerimaan dan pendistribusian alokon.
  - b. Menjaga mutu, keamanan serta ketersediaan alokon.
7. Unit/Bagian lain
  - a. Berperan dalam kegiatan KIE/motivasi calon akseptor potensial.

### 2.3 Distribusi Ketenagaan

Table 2.2 Distribusi Ketenagaan :

| No | Jabatan    | Penempatan                | Kualifikasi | Jumlah SDM | Standart Ketenagaan |
|----|------------|---------------------------|-------------|------------|---------------------|
| 1  | Ketua TIM  | Maternitas<br>IRJA<br>IKO | 3 Shift     | 1          | 1                   |
| 2  | Sekretaris | IRJA                      | 2 Shift     | 1          | 1                   |
| 3  | Anggota 1  | IRJA                      | 2 Shift     | 1          | 1                   |
| 4  | Anggota 2  | Maternitas                | 3 Shift     | 1          | 1                   |
| 5  | Anggota 3  | IKO                       | 3 Shift     | 1          | 1                   |



## 2.4 Pengaturan Jaga

Table 2.3 Pengaturan Jaga tim KBRS :

| No | Nama Jabatan       | Waktu Kerja | Definisi Waktu Kerja                                  | Jumlah SDM |
|----|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Ketua Tim          | 3 shift     | Jam 06.30-14.00<br>Jam 14.00-21.00<br>Jam 21.00-07.00 | 1 orang    |
| 2  | Sekretaris         | 2 Shift     | Jam 06.30-14.30<br>Jam 14.00-22.00                    | 1 orang    |
| 3  | Anggota Maternitas | 3 Shift     | Jam 06.30-14.00                                       | 1 orang    |
|    |                    |             | Jam 14.00-21.00                                       | 1 orang    |
|    |                    |             | Jam 21.00-07.00                                       | 1 orang    |
| 4  | Anggota IKO        | 3 Shift     | Jam 06.30-14.00                                       | 1 orang    |
|    |                    |             | Jam 14.00-21.00                                       | 1 orang    |
|    |                    |             | Jam 21.00-07.00                                       | 1 orang    |
| 5  | Anggota IRJA       | 2 Shift     | Jam 06.30-14.00                                       | 1 orang    |
|    |                    |             | Jam 14.00-21.00                                       | 1 orang    |



### BAB III STANDAR FASILITAS

#### 3.1 Denah Ruang

Ada pada lampiran

#### 3.2 Standar Fasilitas

Letak ruang PKBRS harus di lokasi yang tenang, aman, dan nyaman.

Ruang rawat jalan harus memiliki akses yang mudah ke ruang penunjang pelayanan lainnya

1. Ruang bersalin harus dipisahkan dari ruang rawat inap umum.
2. Ruang operasi harus memiliki akses yang mudah.

Table 3.1 Standar Fasilitas pelayanan Keluarga berencana Rumah sakit :

| No | Nama Ruang       | Persyaratan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Keterangan                                                                             |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ruangan bersalin | <p>Ukuran ruangan bersalin tergantung kelas perawatan dan jumlah tempat tidur.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jarak antar tempat tidur 2,4 m minimal luas per tempat tidur 10 meter persegi; jarak antar-tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Jumlah maksimal tempat tidur per ruangan 4 buah; tempat tidur dapat disesuaikan (<i>adjustable</i>) dan berukuran 200x90x50-80 sentimeter</li><li>2. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.</li><li>3. Antar tempat tidur yang dibatasi oleh tirai maka rel harus dibenamkan/ menempel di plafon, dan sebaiknya bahan tirai non porosif.</li><li>4. Setiap tempat tidur di ruang rawat inap memiliki 2 kotak kontak dan tidak boleh percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus serta bel perawat/nurse call yang terhubung dengan pos perawat/nurse station</li><li>5. Nakas per tempat tidur.</li><li>6. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut.</li><li>7. Pengaturan suhu dalam ruangan rawat inap harus berada pada</li></ol> | Jumlah tempat tidur menyesuaikan dengan klasifikasi RS dan kajian kebutuhan pelayanan. |



|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                     | <p>rentang 20° C hingga 26° C (Suhu kamar). Pengaturan kelembaban ruangan adalah <math>\leq 60\%</math>. Pengukuran suhu dan kelembaban dilakukan menggunakan thermometer dan hygrometer ruangan secara berkala</p> <p>8. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 250 lux untuk penerangan, dan 50 lux untuk tidur.</p> <p>9. Ruang rawat dibagi berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Penyakit (Infeksi, Non Infeksi), dan ruang rawat gabung.</p> <p>10. Di setiap ruangan perawatan harus disediakan kamar mandi. Kamar mandi ini mengikuti persyaratan kamar mandi aksesibilitas.</p> <p>11. Setiap tempat tidur memiliki outlet oksigen yang dilengkapi dengan flowmeter yang berada pada dinding belakang tempat tidur pasien (bedhead).</p> |  |
| 2. | Ruangan rawat jalan | <p>1. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.</p> <p>2. Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut.</p> <p>3. Pengaturan suhu dalam ruangan rawat jalan harus berada pada rentang 20°C hingga 26°C (Suhu kamar). Pengaturan kelembaban ruangan adalah <math>\leq 60\%</math>. Pengukuran suhu dan kelembaban dilakukan menggunakan thermometer dan hygrometer ruangan secara berkala</p> <p>4. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 250 lux untuk penerangan, dan 50 lux untuk tidur</p>                                       |  |



|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. | Ruangan<br>IKO | <p>Pembatasan :</p> <p>1. Zona 1</p> <p>Pakaian dari luar Instalasi Kamar Operasi boleh dipakai.</p> <p>2. Zona 2</p> <p>Pakaian luar Instalasi Kamar Operasi masih boleh dipakai.</p> <p>3. Zona 3</p> <p>Petugas Instalasi Kamar Operasi wajib menggunakan pakaian khusus</p> <p>4. Zona 4</p> <p>Tim Instalasi Kamar Operasi wajib memakai jas operasi.</p> |  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



## BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN

### 4.1 Pelayanan Keluarga berencana Yang Bisa Dilakukan di RSPH

#### A. Klasifikasi Pelayanan KB di RS

Pelayanan KB yang diselenggarakan di rumah sakit mencakup semua jenis alat/obat kontrasepsi baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan pelayanan penanganan efek samping, komplikasi, kegagalan, dan infertilitas.

Pelayanan KB terbagi menjadi beberapa klasifikasi layanan yaitu :

##### 1. Pelayanan KB lengkap

Adalah pelayanan Keluarga Berencana yang meliputi pelayanan kontrasepsi kondom, pil/KB, suntik KB, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD), pemasangan/pencabutan implant, MOW (bagi yang memenuhi persyaratan), serta penanganan efek samping dan komplikasi pada tingkat tertentu sesuai kemampuan dan fasilitas/sarana yang tersedia.

Minimal tenaga yang tersedia :

- Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan atau Dokter Spesialis Bedah terlatih.
- Dokter umum terlatih (jika tidak ada dokter spesialis).
- Bidan terlatih.
- Perawat terlatih.
- Tenaga Konselor
- Dokter Anestesi

##### 2. Pelayanan KB Sempurna

Adalah pelayanan Keluarga Berencana yang meliputi pelayanan KB lengkap ditambah dengan MOW (bagi fasilitas yang memenuhi persyaratan), penanganan kegagalan, dan pelayanan rujukan.

Minimal tenaga yang tersedia :

- Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- Dokter Spesialis Bedah
- Dokter Spesialis Anestesi
- Bidan terlatih
- Perawat terlatih
- Tenaga konselor
- Dokter Anestesi

#### B. Sistem Pelayanan

Pelayanan KB di RS hendaknya memenuhi hal-hal dibawah ini yaitu :

- 1) Pelayanan dilakukan sesuai standar yang berlaku di RS.
- 2) Pelayanan KB di RS dilakukan melalui pendekatan satu atap (*one stop service*) artinya setiap klien/calon akseptor potensial yang membutuhkan pelayanan KB, dapat dilayani kebutuhan Klienya di beberapa unit terkait, dan setelah dilakukan konseling serta pengambilan keputusan mengenai metode kontrasepsi yang dipilih, maka dilakukan pelayanan medis KB ditempat yang telah ditetapkan.





- 3) Pelayanan dilakukan secara terpadu dengan komponen kesehatan reproduksi lainnya, antara lain dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), pelayanan pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual (PP-IMS) dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja (dalam hal ini pemberian informasi tentang KB).
- 4) SDM dan sarana prasana yang tersedia harus memenuhi ketentuan.
- 5) Semua tindakan harus terdokumentasi dengan baik.
- 6) Harus ada sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian kualitas pelayanan.
- 7) Ayoman pasca pelayanan.

#### **B. Langkah-langkah pelaksanaan**

- 1) Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna.
- 2) Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB.
- 3) Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
- 4) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembinaan teknis dalam melaksanakan PKBRS.
- 5) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan KB bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- 6) Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS.
- 7) Adanya regulasi rumah sakit yang menjamin pelaksanaan PKBRS, meliputi SPO pelayanan KB per metode kontrasepsi termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
- 8) Upaya peningkatan PKBRS masuk dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja anggaran (RKA) rumah sakit.
- 9) Tersedia ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk PKBRS antara lain ruang konseling dan ruang pelayanan KB.
- 10) Pembentukan tim PKBR serta program kerja dan bukti pelaksanaannya)
- 11) Terselenggara kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pelayanan PKBRS, termasuk KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
- 12) Pelaksanaan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 13) Pelaporan dan analisis meliputi:
  - a) Ketersediaan semua jenis alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan KB.
  - b) Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB.
  - c) Ketersediaan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB.
  - d) Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.
  - e) Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
  - f) Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalindan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca kegugura



## **BAB V**

### **TATA LAKSANA**

1. Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna
2. Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB
3. Meningkatkan kesiapan Rumah Sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran.
4. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembinaan teknis dalam melaksanakan PKBRS
5. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayan KB bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya
6. Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS
7. Adanya regulasi rumah sakit yang menjamin pelaksanaan PKBRS meliputi SPO Pelayanan KB per metode kontrasepsi termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran.
8. Upaya peningkatan PKBRS masuk dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana belanja anggaran (RBA) rumah sakit
9. Tersedia ruang pelayanan yang memenuhi persyaratan untuk PKBRS antara lain ruang konseling dan ruang pelayanan KB
10. Pembentukan tim PKBRS serta program kerja dan bukti pelaksanaannya
11. Terselenggara kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pelayanan PKBRS termasuk KB Pasca Persalinan Pasca Keguguran
12. Pelaksanaan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB VI LOGISTIK

### 6.1 Alat dan bahan

Table 6.1 Alat dan bahan

| No | Jenis                                                              | Lengkap | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|    | <b>Ruangan</b>                                                     |         |     |
| 1  | R. Tunggu & pendaftaran serta KIE medis                            | √       |     |
| 2  | R. Periksa & Pelayanan kontrasepsi                                 | √       |     |
| 3  | R. Operasi                                                         | √       |     |
| 4  | R. Perawatan pasca bedah                                           | √       |     |
| 5  | R. Lab lengkap                                                     | √       |     |
| 6  | Kamar kecil /WC                                                    | √       |     |
|    | <b>Peralatan Medis</b>                                             |         |     |
| 1  | Meja ginekologi                                                    | √       |     |
| 2  | Tensimeter                                                         | √       |     |
| 3  | Stetoskop                                                          | √       |     |
| 4  | Implant kit                                                        | √       |     |
| 5  | IUD Kit                                                            | √       |     |
| 7  | Minilaparoskop kit                                                 | -       |     |
| 8  | Laparoskop                                                         | -       |     |
| 9  | Emergensi kit                                                      | √       |     |
| 10 | Sterilisator                                                       | √       |     |
| 11 | Alat suntik                                                        | √       |     |
| 12 | Perlengkapan & obat secukupnya untuk yang kontap IUD, Implant, MOW | √       |     |
| 13 | Histeroskop                                                        | -       |     |
| 14 | Peralatan untuk rekanalisasi                                       | -       |     |
| 15 | Peralatan penanggulangan infertilitas                              | -       |     |



| No                                     | Jenis                                   | Lengkap | Ket |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----|
| <b>Peralatan Non Medis</b>             |                                         |         |     |
| 1                                      | Timbangan BB                            | √       |     |
| 2                                      | Tempat tidur periksa                    | √       |     |
| 3                                      | Bangku kecil untuk naik ke tempat tidur | √       |     |
| 4                                      | Meja alat                               | √       |     |
| 5                                      | Wastafel                                | √       |     |
| 6                                      | Papan nama fasilitas pelayanan          | √       |     |
| 7                                      | Lemari penyimpanan alokon               | √       |     |
| <b>Persediaan Alokon</b>               |                                         |         |     |
| 1                                      | Kondom                                  | √       |     |
| 2                                      | Pil KB                                  | √       |     |
| 3                                      | Suntikan                                | √       |     |
| 4                                      | IUD                                     | √       |     |
| 5                                      | Implant                                 | √       |     |
| <b>Media KIE &amp; KIP / Konseling</b> |                                         |         |     |
| 1                                      | Poster                                  | √       |     |
| 2                                      | Lembar balik                            | √       |     |
| 3                                      | Booklet                                 | √       |     |
| 4                                      | Kartu Informasi                         | √       |     |
| 5                                      | Media elektronik                        | √       |     |

## 6.2 Sumber dan mekanisme distribusi Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)

Alat/obat kontrasepsi yang digunakan dalam pelayanan KB di RS bagi keluarga yang kurang mampu bersumber dari :

1. APBN BKKBN
2. APBD Provinsi, Kabupaten/Kota

Bagi keluarga mampu, menggunakan alat/obat kontrasepsi mandiri yang disediakan oleh Rumah Sakit



## **BAB VII**

### **KESELAMATAN PASIEN**

#### **7.1. Pengertian**

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi penilaian resiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

Keselamatan pasien pada pelayanan keluarga berencana rumah sakit merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien, mengingat setiap tindakan membutuhkan perhatian yang lebih dan membutuhkan penanganan jangka panjang yang perlu keseriusan dari tenaga kesehatan untuk menghindari terjadinya kesalahan penanganan dalam praktiknya. Kejadian yang mengacu pada keselamatan pasien diantaranya pasien terjatuh dari tempat tidur, pasien diberi obat salah, tidak ada obat/alat emergensi, tidak ada oksigen, tidak ada alat penyedot lendir, tidak tersedia alat pemadam kebakaran, dan pemakaian obat.

#### **7.2. Tujuan**

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit.
2. Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat.
3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di RS.
4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan.

#### **7.3. Standar Keselamatan Pasien**

1. Mengidentifikasi pasien dengan benar
2. Meningkatkan komunikasi yang efektif
3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai
4. Memastikan sisi yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/ Tindakan invasif
5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan
6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh

#### **7.4. Kejadian Yang Dapat Muncul Dalam Pelayanan**

Kesalahan dalam sasaran keselamatan pasien bisa menyebabkan kematian dalam pelayanan, yaitu bisa menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan. Contoh dalam hal ini adalah kesalahan dalam mengidentifikasi pada saat sebelum melakukan Tindakan, identifikasi tidak dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO).



### 7.5. Tata Laksana

1. Mengidentifikasi pasien dengan benar
  - a. Setiap pasien yang masuk kamar bersalin dan kamar operasi dipasangkan gelang identitas pasien.
  - b. Bila pasien ada resiko jatuh diberi stiker warna kuning dan bila pasien ada alergi diberi stiker warna merah di gelang identitas pasien
  - c. Ada dua identitas yang digunakan yaitu nama dan tanggal lahir yang disesuaikan dengan tanda pengenalan resmi.
  - d. Identifikasi pasien dilakukan pada saat sebelum : Melakukan Tindakan (misalnya Tindakan MOW dan pemberian obat kontrasepsi).
2. Meningkatkan komunikasi yang efektif
  - a. Metode, formulir dan alat bantu ditetapkan sesuai dengan jenis komunikasi agar dapat dilakukan secara konsisten dan lengkap
  - b. Metode komunikasi saat menerima instruksi melalui telepon adalah : menulis/ menginput ke computer – membackan – konfirmasi kembali (*writedown, read back, confirmation*)
  - c. Saat melaporkan metode yang digunakan adalah *Situation – Background – Assessment – Recommendation* (SBAR)
  - d. Metode komunikasi saat melaporkan nilai kritis pemeriksaan diagnostic melalui telpon juga dengan menggunakan menulis/ menginput ke computer – membackan – konfirmasi kembali (*writedown, read back, confirmation*)
  - e. Metode komunikasi saat serah terima antar ruangan dan atau di dalam ruangan menggunakan formulir khusus
3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai
  - a. Obat risiko tinggi yaitu obat dengan zat kimia yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan bila terjadi kesalahan dalam penggunaannya
  - b. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (nama obat rupa dan ucapan mirip/ NORUM, atau LASA(look alike sound alike))
  - c. Elektrolit konsentrat yang melebihi 50%, contoh : KCL 3%, NS 3%.
  - d. Ada protocol dalam pemberian terapi dalam menanggulangi hypokalemia, hyponatremia, dan hipofastemia yang sudah tertera dalam PPK (panduan praktek klinis)
4. Memastikan sisi yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/ Tindakan invasive
  - a. Tindakan operasi dan invasive meliputi semua tindakan yang melibatkan insisi atau pungsi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, operasi terbuka, aspirasi perkutan, injeksi obat tertentu, biopsy, tindakan intervensi atau diagnostic vaskuler dan kardiak perkutan, laparaskopi, ekstraksi gigi, ESWL, dan endoskopi.
  - b. Penandaan sisi operasi dilakukan dengan melibatkan pasien
  - c. Penandaan lokasi tindakan operasi/ invasive dilakukan oleh PPA yang akan melakukan tindakan tersebut
  - d. PPA tersebut akan melakukan seluruh prosedur operasi/ invasive dan tetap berada dengan pasien selama tindakan berlangsung
  - e. Pada tindakan operasi, dokter operator/ dokter penanggung jawab pasien (DPJP) bedah akan melakukan tindakan penandaan lokasi



- f. Tindakan invasive non-operasi, penandaan dilakukan oleh dokter yang akan melakukan tindakan
  - g. Penandaan dapat dilakukan di area luar kamar operasi
  - h. Penandaan sisi operasi dilakukan dengan melibatkan pasien serta dengan tanda yang tidak memiliki arti ganda serta segera dapat dikenali yaitu dengan tanda lingkaran dan panah pada area yang akan dilakukan tindakan
  - i. Tanda harus terlihat sampai pasien disiapkan
  - j. Penandaan sisi operasi hanya ditandai pada semua kasus yang memiliki dua sisi kiri dan kanan (lateralisasi), struktur multiple (jari tangan, jari kaki, lesi) atau multiple level (tulang belakang)
5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan  
Kebersihan tangan merupakan hal yang paling penting untuk mencegah penyebaran infeksi. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun harus segera dilakukan terutama saat tangan terlihat kotor atau terkontaminasi dengan bahan-bahan dari tubuh pasien. Penggunaan handrub dengan bahan alkohol dapat dilakukan secara rutin untuk memastikan tangan bebas dari kontaminasi atau hanya jika tangan tidak terlihat kotor, bukan menggantikan fungsi cuci tangan. Lakukan cuci tangan pada momen yang tepat, yaitu :
  - a. Sebelum kontak langsung dengan pasien.
  - b. Setelah kontak langsung dengan pasien.
  - c. Sebelum melakukan tindakan invasif pada pasien.
  - d. Setelah terkena cairan tubuh pasien.
  - e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien
6. langkah cuci tangan menggunakan handwash sebagai berikut :
  - a. Basahi tangan dengan air mengalir yang bersih (kran, air yang dituangkan dari wadahnya mengalir tangan). Ambil 3-5cc sabun cair, ratakan dengan kedua telapak tangan.
  - b. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan jari-jari tangan kanan dan sebaliknya.
  - c. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua telapak tangan.
  - d. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci.
  - e. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggam tangan kanan dan sebaliknya.
  - f. Gosok arah berputar ujung-ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya.
  - g. Bilas kedua tangan dengan air mengalir.
  - h. Keringkan dengan handuk sekali pakai atau tisu sampai benar-benar kering.
  - i. Tutup kran dengan handuk sekali pakai atau tisu
7. Mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh
  - a. Pengkajian risiko jatuh pada semua pasien rawat inap baik dewasa maupun anak dilakukan sesuai regulasi Panduan Upaya Mengurangi Cedera Pasien Akibat Jatuh
  - b. Pengkajian ulang risiko jatuh pada pasien rawat inap dilakukan pada saat terjadi perubahan kondisi, atau memang sudah mempunyai risiko jatuh dari hasil pengkajian
  - c. Tindakan dan/ atau intervensi untuk mengurangi risiko jatuh pada pasien rawat inap telah dilakukan dan didokumentasikan





## BAB VIII

### KESELAMATAN KERJA

#### 8.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit agar terciptanya kondisi Rumah Sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit, maka Rumah Sakit perlu menerapkan SMK3 Rumah Sakit. SMK3 Rumah Sakit merupakan bagian dari sistem manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan.

#### 8.2 Pengertian

Pengertian K3 Menurut Filosofi Mangkunegara, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.

#### 8.3 Tujuan

1. Terciptanya budaya keselamatan kerja di RS Prima Husada.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
3. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
4. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

#### 8.4 Tata Laksana Keselamatan Kerja

Mengacu pada pengertian tersebut maka diharapkan setiap petugas rumah sakit dapat menerapkan sistem keselamatan kerja diantaranya:

1. Petugas mengerti SPO penggunaan APD sehingga dapat menggunakan APD sesuai prosedur.
2. Tersedianya APD yang memenuhi standar.
3. Tersedianya tempat pembuangan sampah yang dibedakan infeksius dan non infeksius serta terdapatnya tempat khusus untuk pembuangan jarum atau pun spuit bekas.
4. Aturan untuk tidak melakukan recuping jarum suntik setelah dipakai ke pasien.
5. Setiap pasien yang menular atau beresiko menular di rawat di ruang isolasi.
6. Setiap petugas medis maupun non medis menjalankan prinsip pencegahan infeksi, yaitu
  - a. Menganggap bahwa pasien maupun dirinya sendiri dapat menularkan infeksi
  - b. Menggunakan alat pelindung (hazmat/ skort, sarung tangan, kacamata, sepatu boot/ alas kaki tertutup, celemek, masker, dll) terutama bila terdapat kontak dengan spesimen pasien yaitu: urin, darah, muntah, sekret, dll
  - c. Melakukan tindakan yang aman bagi petugas maupun pasien, sesuai prosedur yang ada, misal : memasang kateter, menyuntik, menjahit luka, memasang infus, dll
  - d. Mencuci tangan dengan sabun antiseptik pada 5 momen.





7. Terdapat tempat sampah infeksius dan noninfeksius.
8. Mengelola alat dengan mengindahkan prinsip sterilitas yaitu:
  - a. Dekontaminasi dengan larutan klorin
  - b. Pencucian dengan sabun
  - c. Pengeringan
9. Menggunakan baju kerja yang bersih

#### **8.5 Prinsip Keselamatan Kerja**

Dalam prinsip kesehatan keselamatan kerja (K3) secara utuh di rumah sakit ada 3 komponen penting yang saling berhubungan, antara lain :

1. Kapasitas kerja, kemampuan seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik pada suatu tempat kerja dalam waktu tertentu.
2. Beban kerja, suatu kondisi yang membebani pekerja baik secara fisik maupun non fisik dalam menyelesaikan pekerjaannya, kondisi tersebut dapat diperberat oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung secara fisik atau non fisik.
3. Lingkungan kerja, kondisi lingkungan tempat kerja yang meliputi factor fisik, kimia, biologi, ergonomic dan psikososial yang mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.



## BAB IX PENINGKATAN MUTU

### 9.1 Prinsip

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu, pelayanan rawat inap harus mempunyai suatu ukuran yang menjamin peningkatan mutu. Dalam kegiatan peningkatan mutu pelayanan rawat inap perlu ada suatu program yang terencana dan berkesinambungan sebagai pedoman bagi pelayanan rawat inap dalam mengevaluasi dan membuat rencana tindak lanjut sehingga tercapai peningkatan mutu pelayanan yang diharapkan. Indikator yang digunakan adalah dengan menggunakan Indikator PMKP.

### 9.2 Definisi Indikator

1. Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP.
2. Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
3. Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.

### 9.3 Kriteria

1. Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi,
2. Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan
3. Angka capaian pelayanan KB Pasca Keguguran.
4. Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin
5. Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.

### 9.4 Standar

Standar yang dinilai pada kriteria diatas adalah 100% pada angka capaian dan jumlah 0 pada kejadian.

1. Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi,  
$$\frac{\text{Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi}}{\text{Jumlah sasaran total per bulan}} \times 100\%$$
2. Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan  
$$\frac{\text{Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan}}{\text{jumlah pasien bersalin total per bulan}} \times 100\%$$
3. Angka capaian pelayanan KB Pasca Keguguran  
$$\frac{\text{Angka capaian pelayanan KB Pasca Keguguran}}{\text{Jumlah pasien keguguran total per bulan}} \times 100\%$$
4. Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin  
Jumlah total pasien bersalin – jumlah pasien yang tidak dilakukan KB Pasca Persalinan
5. Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran.  
Jumlah total pasien keguguran – jumlah pasien yang tidak dilakukan KB pasca keguguran



## **BAB X**

### **PENUTUP**

Pelayanan keluarga berencana Rumah sakit adalah bagian pelayanan dari Rumah Sakit Prima Husada yang memberikan pelayanan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Dengan adanya pedoman pelayanan keluarga berencana rumah sakit diharapkan dapat membantu dalam memberikan pelayanan khususnya tim PKBRS dan dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh staf rumah sakit terutama PPA dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Sehingga asuhan pelayanan pasien dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan yang berdampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan pasien karena kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Prima Husada.

Ditetapkan di Malang  
Pada Tanggal 1 Juni 2025  
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah



---

---